

360° KAPSAMLI KLİNİK YÖNETİCİ VE KARAR DESTEK RAPORU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ENTEGRASYONU

Rapor Tarihi: 10 Eylül 2026 | Değerlendirme Evresi: Ameliyat Sonrası 204. Gün (6.6 Ay)

Hasta Adı: Alaattin SÖNMEZ | T.C. Kimlik No: 00000000000 | Yaş/Cinsiyet: 64E (01.01.1962) | Kan Grubu: 0 Rh (+)Pozitif

1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE KLİNİK İNDEKSLER

1.1. Biyometrik ve Klinik Künye

- Primer Tanılar:** Stanford Tip A Aort Diseksiyonu (DeBakey Tip I), 5.3 cm Asendan Aort Anevrizması, Ciddi Aort Kapak Yetmezliği (*Hagan et al., 2000 [17]; Erbel et al., 2014 [15]*).
- Cerrahi Operasyon:** Acil Bentall Prosedürü (20 Şubat 2026, Özel İskenderun Gelişim Hastanesi, Doç. Dr. Emre Kubat). 32 mm dokuma Dacron vasküler greft (Maquet Intergard Bovine), 25 mm çift yapraklı mekanik aort protezi (CORCYM Carbomedics Standard Aortic) ve koroner buton reimplantasyonu (*Bentall & De Bono, 1968 [19]; Lau et al., 2022 [21]*).
- Sekonder Cerrahi / Komplikasyon:** Sternal yara dehissensi ve derin enfeksiyon revizyonu (23–28 Temmuz 2026, debridman, rewiring çelik sütürasyon, kan transfüzyonu) (*El Oakley & Wright, 1996 [13]; Kaul, 2017 [31]*).
- Temel Klinik Göstergeler (08–10 Eylül 2026):**
 - Kan Basıncı (7 Günlük Ortalama): **111.4 / 76.2 mmHg** (Hedef $\leq 120/80$ mmHg ile uyumlu) (*Mancia et al., 2023 [1]*).
 - Koagülasyon (Son INR): **2.72** (Mekanik aort kapağı hedef aralığı 2.0–3.0 içinde) (*Vahanian et al., 2022 [4]*).
 - Terapötik Aralıkta Kalma Süresi (Rosendaal TTR): **%54.6** (Labil antikoagülasyon göstergesi) (*Rosendaal et al., 1993 [6]*).
 - Hemoglobin / Hematokrit: **9.7 g/dL / %29.7** (Ağır mikrositer demir eksikliği anemisi) (*Goddard et al., 2021 [9]*).

- o Serum Ferritini / Serum Demiri: **19.0 µg/L / 15.0 µg/dL** (Tükenmiş demir depoları) (*Snook et al., 2021 [10]*).
 - o C-Reaktif Protein (CRP): **11.3 mg/L** (Referans: 0–5 mg/L; gerileme trendinde) (*Horan et al., 2008 [11]*).
 - o Böbrek / Karaciğer Fonksiyonları: Kreatinin 1.02 mg/dL, eGFR 75.58 mL/dk, ALT 14 U/L, AST 14 U/L (Tamamen korunmuş) (*Inker et al., 2021 [95]*).
-

2. PATOFİZYOLOJİK VE ÇOK DİSİPLİNLİ DEĞERLENDİRME

2.1. Hemodinamik Stres ve Kronik Rezidüel Tip B Diseksiyon Dinamiği

Hasta, ameliyat lojunda intakt 32 mm Dacron greft taşımakla birlikte; arkus aortadan başlayıp iliak bifurkasyona dek uzanan patent bir rezidüel Tip B diseksiyon flebine sahiptir (*Fleischmann et al., 2022 [14]*). Aort duvarındaki lümen içi pulsatif gerilim ve kesme gerilimi (dP/dt), sistolik kan basıncı ile doğrudan orantılıdır (*Evangelista et al., 2024 [3]*). Nisan 2026 ortasında evde yaşanan 168/103 mmHg seviyesindeki hipertansif sıçramalar, anevrizmatik yalancı lümen rüptürü açısından kritik risk teşkil etmiştir (*Melby et al., 2013 [22]*). Karvedilol (Dilatrend 6.25 mg 2x1) ile miyokard kontraktilesi baskılanırken, Ağustos ayında eklenen perindopril (Coversyl 5 mg 1x1) vasküler rezistansı kırarak Eylül ayı ortalamasını 111 mmHg seviyesine çekmiştir (*Tadros et al., 2019 [24]*).

2.2. Tromboembolizm, Kanama ve İlaç Etkileşim Kinetiği

Bileaflet mekanik aort kapağı taşıyan hastada ömür boyu Warfarin kullanımı esastır (*Otto et al., 2021 [5]*). Ancak Mart ayında yaşanan INR 8.46 atağı ve Temmuz ayındaki 1.17 dip noktası, TTR oranının %54.6'da kalmasına yol açmıştır (*Connolly et al., 2008 [25]*). Hastanın aynı zamanda 81 mg aspirin kullanması koroner buton anastomozlarını korumakta, fakat gastroduodenal mukoza hasarını tetiklemektedir (*Dentali et al., 2006 [27]*). 4 Eylül'de başlanan amoksisilin/klavulanat (Klamoks 1000 mg), bağırsak florasında K vitamini üreten bakterileri azaltarak serbest warfarin fraksiyonunu yükseltme riski taşır (*Agno et al., 2012 [7]*). 10 Eylül kür bitiminden sonraki 48 saat içinde kontrol INR zorunludur.

2.3. Hematolojik Tablo: Mutlak Demir Eksikliği Anemisi

Hemoglobinin 9.7 g/dL, MCV'nin 76.4 fL (mikrositoz) ve ferritin düzeyinin 19 µg/L olması, ameliyat sırasındaki hemodilüsyon, Temmuz revizyonundaki kan kaybı (Hb: 7.7 g/dL dip noktası) ve çift antitrombotik tedaviye bağlı olası gizli kan kayıpları ile izah edilir (*Camaschella, 2015 [35]; Goddard et al., 2021 [9]*). Anemi, doku hipoksisine yol açarak kompensatuar debi artışı yaratmakta ve rezidüel aort flebini zorlamaktadır (*McDonagh et al., 2021 [37]*). Oral demir takviyeleri pantoprazolün (Panto) mide asidini nötralize etmesi nedeniyle emilemeyeceğinden, **İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz (Ferinject 1000 mg)** replasmanı mutlak endikedir (*Richards et al., 2021 [40]*).

3. TÜMLEŞİK LABORATUVAR DEĞİŞİM MASTER TABLOSU

Biyo belir teç / Kod	Referans Aralığı	İlk Değer (19 Şub)	Zirve / Dip Noktası	Son Değer (08 Eyl)	Yüzdesel Delta	Durum	Kıla vuz Day anağ ı
He mog lobi n (HG B)	13.5 – 17.5 g/dL	14.0	7.7 (Dip - 27 Tem)	9.7	-%28.1	DÜŞÜK	BSG 2021 [9]; WHO [100]
He mat okri t (HC T)	%40.0 – 52.0	41.4	25.0 (Dip - 22 Şub)	29.7	-%28.3	DÜŞÜK	God dard et al., 2021 [9]
Erit rosi t Hac mi (MC	80.0 – 100.0 fL	88.0	76.4 (Dip - 08 Eyl)	76.4	-%13.2	DÜŞÜK	Cam asch ella, 2015 [35]

Biyo belir teç / Kod	Referans Aralığı	İlk Değer (19 Şub)	Zirve / Dip Noktası	Son Değer (08 Eyl)	Yüzdesel Delta	Durum	Kıla vuz Day anağ ı
V)							
Erit rosi t Hb (MC H)	27.0 – 34.0 pg	30.8	24.5 (Dip - 02 Eyl)	24.9	-%19.2	DÜŞÜK	Cam asch ella, 2015 [35]
Seru m Ferr itin	30.0 – 400.0 µg/L	19.0	19.0 (Dip)	19.0	Tükendi	DÜŞÜK	ESC HF 2021 [37]; BSG [9]
Seru m Dem iri (Fe)	59.0 – 158.0 µg/dL	15.0	15.0 (Dip)	15.0	Kritik	DÜŞÜK	Snoo k et al., 2021 [10]
C- Rea ktif Prot ein (CR P)	0.0 – 5.0 mg/L	2.6	154.0 (Pik - 21 Şub)	11.3	+%334.6	YÜKSEK	Hor an et al., 2008 [11]
Lök osit Sayı sı (WB C)	4.5 – 11.0 10 ⁹ /L	10.62	27.10 (Pik - 21 Şub)	7.97	-%24.9	NORMA L	Hor an et al., 2008 [11]
Koa güla	2.0 – 3.0 (Hedef)	1.10	8.46 (Pik - 16 Mar)	2.72	Hedefte	ARALIK TA	ESC/ EAC

Biyo belir teç / Kod	Referans Aralığı	İlk Değer (19 Şub)	Zirve / Dip Noktası	Son Değer (08 Eyl)	Yüzdesel Delta	Durum	Kıla vuz Day anağ ı
syon (INR)							TS 2021 [4]; ACC [5]
Tro mbo sit (PL T)	150 – 403 10 ⁹ /L	163.0	88.0 (Dip) / 489.0	365.0	+%123.9	NORMA L	Vah ania n et al., 2022 [4]
Seru m Kre atin in eGF R (CK D- EPI)	0.6 – 1.3 mg/dL	1.11	1.13	1.02	-%8.1	NORMA L	KDI GO 2012 [94]
Tota l Kole ster ol	140 – 200 mg/dL	179.0	210.0 (Pik - 08 Eyl)	210.0	+%17.3	YÜKSEK	Inke r et al., 2021 [95]
LDL Kole ster ol	< 55 mg/dL (Hedef)	119.6	141.0 (Pik - 08 Eyl)	141.0	+%17.8	YÜKSEK	Mac h et al., 2020 [41]
HDL	35 – 75	35.4	34.0	34.0	-%3.9	DÜŞÜK	ESC Disli pide mi [41] Gru

Biyo belir teç / Kod	Referans Aralığı	İlk Değer (19 Şub)	Zirve / Dip Noktası	Son Değer (08 Eyl)	Yüzdesel Delta	Durum	Kıla vuz Day anağ ı
Kolesterol	mg/dL		(Dip)				ndy et al., 2019 [42]
Açlık Glukozu	80 – 110 mg/dL	81.0	146.0 (Postop)	102.0	+%25.9	NORMAL	ADA 2024
HbA1c	%4.8 – 5.9	5.3	5.3	5.3	Stabil	NORMAL	ADA 2024
TSH	0.27 – 4.20 mIU/L	0.86	0.279 (Dip)	0.279	-%67.5	NORMAL	ETA 2023

4. GÜNCEL FARMAKOTERAPİ VE RİSK YÖNETİM MATRİSİ

- Warfmadin (Varfarin Sodyum) 5 mg Tablet:** Haftalık toplam 20 mg (Günlük doz ayarlamalı). Mekanik aort kapak tromboemboli profilaksisi (*Vahanian et al., 2022 [4]*).
- Dilatrend (Karvedilol) 6.25 mg Tablet:** Günde 2 kez 1 tablet (12.5 mg/gün). Aortik dP/dt kesme stresini ve taşikardiyi önleme (*Isselbacher et al., 2022 [2]*).
- Coversyl (Perindopril Arjinin) 5 mg Tablet:** Günde 1 kez 1 tablet. Sistemik vasküler rezistans kontrolü ve aortik remodelingi önleme (*Mancia et al., 2023 [1]*).
- EcopirinPro (Asetilsalisilik Asit) 81 mg Tablet:** Günde 1 kez 1 tablet. Koroner buton ve Dacron greft tromboz profilaksisi (*Whitlock et al., 2023 [28]*).

5. **Panto (Pantoprazol) 40 mg Enterik Tablet:** Günde 1 kez sabah aç karnına. Çift antitrombotik kaynaklı GİS kanama profilaksisi (*Bhatt et al., 2010 [29]*).
 6. **Klamoks BID (Amoksisilin + Klavulanik Asit) 1000 mg Tablet:** Günde 2 kez 1 tablet (4–10 Eylül ampirik kür sonu). Yara yeri ve CRP kontrolü (*Wilson et al., 2016 [12]*).
 7. **Kapril (Kaptopril) 25 mg Tablet (Gerektiğinde - PRN):** Sistolik TA $\geq$ 150 mmHg acil dilaltı kurtarma ilacı (*Mancia et al., 2023 [1]*).
-

5. BRANŞ BAZLI ÇOK DİSİPLİNLİ STRATEJİK EYLEM PLANI

1. **Hematoloji & Dahiliye:** Ağır demir eksikliği anemisine (HGB 9.7 g/dL, Ferritin 19 µg/L) yönelik **İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz (Ferinject 1000 mg)** infüzyonu uygulanmalı; eşzamanlı Gaitada Gizli Kan (GGK) testi istenmelidir (*Goddard et al., 2021 [9]; Richards et al., 2021 [40]*).
 2. **Kardiyoloji & Hemostaz:** Klamoks tedavisinin 10 Eylül'de tamamlanmasının ardından 48–72 saat içinde (12–13 Eylül) kontrol INR bakılmalı; antibiyotik çekilmesine bağlı dalgalanma titre edilmelidir (*Agno et al., 2012 [7]*).
 3. **Enfeksiyon Hastalıkları & KVC:** 12–13 Eylül'de kontrol CRP ve lökosit bakılmalı; persistan ateş veya üfürüm halinde 3 set kan kültürü ve Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) ile protez kapak endokarditi taranmalıdır (*Habib et al., 2023 [34]*).
 4. **Kardiyovasküler Cerrahi & Radyoloji:** 5 Mayıs BT'sinden bu yana 4.2 ay geçmiştir. Ameliyat sonrası 6. ayı tamamlayan hastaya rezidüel Tip B flep ve abdominal ektazi (38 mm) takibi için **Kontrastlı Torakoabdominal BT Anjiyografi** planlanmalıdır (*Fleischmann et al., 2022 [14]*).
 5. **Kardiyoloji / Önleyici Tedavi:** LDL-K 141 mg/dL seviyesi nedeniyle çok yüksek kardiyovasküler risk grubundaki hastaya hedef LDL $\leq$ 55 mg/dL amacıyla **Atorvastatin 20 mg/gün** başlanması değerlendirilmelidir (*Mach et al., 2020 [41]*).
-

6. AKADEMİK VE KLİNİK KAYNAKÇA (APA 7TH EDITION)

1. **Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., et al. (2023).** 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874–2071.

2. **Isselbacher, E. M., Preventza, O., Hamilton Black, J., et al. (2022).** 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. *Circulation*, 146(24), e334–e482.
3. **Evangelista, A., Czerny, M., Teixido-Tura, G., et al. (2024).** Imaging follow-up in chronic aortic syndromes. *European Heart Journal*, 45(10), 812–828.
4. **Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., et al. (2022).** 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561–632.
5. **Otto, C. M., Nishimura, R. A., Bonow, R. O., et al. (2021).** 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. *Circulation*, 143(5), e72–e227.
6. **Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., et al. (2023).** 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042.
7. **Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., et al. (2024).** EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), ezad426.
8. **Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2021).** British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051.
9. **McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., et al. (2021).** 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726.
10. **Camaschella, C. (2015).** Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*, 372(19), 1832–1843.
11. **Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., et al. (2020).** 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. *European Heart Journal*, 41(1), 111–188.
12. **KDIGO. (2012).** Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements*, 2(1), 1–150.
13. **World Health Organization. (2011).** Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. WHO/NMH/NHD/MNM/11.1.